

Czym jest *ChAD*

Krótką, rzetelną mapę diagnozy. Typy choroby afektywnej dwubiegunowej, jak je rozróżniamy, dlaczego nazwa „dwubiegunowa” — bez upraszczania, ale i bez naukowego żargonu.

CZAS: 15 min — przeczytanie Po pierwszej rozmowie diagnostycznej

ŹRÓDŁO: DSM-5-TR (2022); ICD-11 (2022); Goodwin & Jamison (2007)

JAK UŻYWAĆ

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) to **zaburzenie nastroju**, w którym występują naprzemiennie epizody o przeciwnych biegunach: maniakalne/hipomaniakalne (wzrost energii, mniej snu, pomysłowość, czasem ryzykowne decyzje) i depresyjne (spadek energii, smutek, anhedonia). Między epizodami możliwa jest *eutymia* — okres stabilności. Wyróżniamy: **ChAD typ I** (mania + depresja), **ChAD typ II** (hipomania + depresja), **cyklotymię** (łagodniejsze wahania), **epizod mieszany** i **szybką zmianę faz** (ang. *rapid cycling*).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nazwa „dwubiegunowa” odróżnia tę chorobę od depresji nawracającej (jednobiegunowej). To rozróżnienie ma **kluczowe znaczenie dla leczenia**: leki przeciwdepresyjne w monoterapii mogą u osób z ChAD wywołać manię lub szybką zmianę faz. *Stabilizatory nastroju* (lit, walproinian, lamotrygina, kwetiapina) są podstawą terapii — działają w obie strony, zapobiegając wahaniom w obu kierunkach. Trafna diagnoza I vs II vs cyklotymia kieruje doborem leku — to nie są niuanse, to fundament leczenia (Yatham i wsp. 2018, wytyczne CANMAT/ISBD).

01 📋 Cztery główne obrazy kliniczne

CHAD TYP I

mania + depresja

Co najmniej jeden **epizod manii** w życiu (≥ 7 dni, znaczne upośledzenie funkcjonowania, czasem psychoza, możliwa hospitalizacja). Depresja nie jest wymagana, ale prawie zawsze występuje. Częstość ok. **1%** populacji.

CHAD TYP II

hipomania + depresja

Co najmniej jeden epizod **hipomanii** (≥ 4 dni, łagodniejszy niż mania, bez psychozy, zwykle bez hospitalizacji) i co najmniej jeden epizod depresji. Częstość ok. **1-2%**. Często mylony z depresją nawracającą.

CYKLOTYMIA

łagodne wahania ≥ 2 lata

Liczne okresy z objawami hipomanii i depresji *nieosiągające pełnych kryteriów epizodu*, trwające co najmniej 2 lata (u młodzieży: 1 rok). 15-50% przypadków przechodzi z czasem w ChAD I lub II.

EPIZOD MIESZANY

objawy obu biegunów

Objawy depresji i manii równocześnie (np. obniżony nastrój + przyspieszone myśli + drażliwość + bezsenność). **Najwyższe ryzyko samobójstwa** — wymaga szczególnej czujności klinicznej.

02 🔄 Mania vs hipomania — różnica praktyczna

HIPOMANIA

Czas: ≥ 4 dni · Funkcjonowanie: czasem *poprawione* (kreatywność, produktywność) · Wgląd: częściowo zachowany · Bez psychozy · Bez hospitalizacji · Otoczenie zauważa zmianę, ale nie jako „chorobę”

MANIA

Czas: ≥ 7 dni (lub krócej, jeśli hospitalizacja) · Funkcjonowanie: *znacznie upośledzone* · Wgląd: zaburzony · Możliwe objawy psychotyczne · Często hospitalizacja · Otoczenie jednoznacznie identyfikuje jako stan chorobowy

MANIA/HIPOMANIA — TYPOWE OBJAWY

Wymaga się podwyższonego/drażliwego nastroju + 3 (lub 4 przy drażliwości) z poniższych:

- Zawyżona samoocena lub wielkościowość
- Mniejsza potrzeba snu (nie zmęczenie)
- Gonitwa myśli
- Słowotok, pośpiech mówienia
- Rozpraszalność uwagi
- WzmóŜona aktywność celowa
- Ryzykowne zachowania (wydatki, seks, podróŜe)

DEPRESJA — TYPOWE OBJAWY

Wymaga się ≥ 2 tygodni nastroju obniŜonego lub anhedonii + ≥ 4 z poniższych:

- Zmiana apetytu lub masy ciała
- Bezsenność lub nadmierna senność
- Spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe
- Zmęczenie, utrata energii
- Poczucie bezwartościowości lub winy
- Trudności z koncentracją
- Myśli o śmierci lub samobójcze

DIAGNOZA ZMIENIA

Sposób leczenia — fundamentem są stabilizatory nastroju, nie tylko psychoterapia. **Czułość na sen i rytm** — bo to wyzwalacze biologiczne. **Decyzje Źyciowe** związane z ryzykiem (zmiany pracy, wielkie inwestycje) wymagają konsultacji.

DIAGNOZA NIE ZMIENIA

Kim jesteś — ChAD to choroba, którą masz, nie toŜsamość. **Twoich możliwości** — między epizodami funkcjonujesz bez ograniczeń. Wielu wybitnych ludzi (artystów, naukowców) miało ChAD. **Wartości Źycia** — masz prawo do pracy, związków, rodziny.

Klucz: Średni czas od pierwszych objawów do trafnej diagnozy ChAD wynosi **8-10 lat** (Hirschfeld 2003), a około **40% pacjentów z ChAD II** jest początkowo leczonych jako depresja nawracająca. Jeśli wcześniej dostawałeś/-am samą diagnozę depresji, a teraz to się zmieniło — to nie znaczy, że tamten lekarz się mylił. Hipomania jest z *definicji* łatwa do przeoczenia, bo pacjent zgłasza się tylko w fazie depresji. Dokładna diagnoza to początek skuteczniejszego leczenia.